

안이비 13주차

01 인두 편도 질환

인두염

가. 급성 인두염

- 傷寒, 咳嗽咽痛 구분

→ 기침을 반복하면서 목에 통증이 생기는게 해수인통. 상한인통이 주가 됨

- 원인: 감기, influenza, 과로, 한기 노출 등에 의한 저항력 저하, 홍역 폐렴 성홍열 백일해 등의 전구증상, 심한 경우 세균, virus 감염, 자극성 가스, 화학물질, 증기 흡입 등

- 증상: 인두종통 + 인건, 이물감, 건조감, 마른 기침, 미열에서부터 심한 통증, 연하곤란, 음식물을 넘길 때 몹시 아프고 귀쪽으로 방산통, 39℃ 이상의 고열, 두통, 전신권태, 식욕 부진, 구취 등 다양

- 국소소견: 인두점막 발적종창, 군데군데 점액농성 분비물. 인두후벽 림프여포가 팔알크기로 발적종창. 목젖 발적종창되고 전후구개궁도 발적. 설태는 희고 역한 입냄새

- 합병증: 급성 중이염, 비염, 부비동염, 후두염, 기관지염, 폐렴, 신염, 급성 류마티스관절염, 패혈증 등

- 치료: 자연 치유 경향. 정상적인 체온이 48시간 이상 계속될 때까지 안정, 가벼운 음식 섭취, 온수 함수, 충분한 수분 공급

- 처방: 麻杏甘石湯, 小青龍湯, 荊防敗毒散, 人蔘敗毒散 등 → 상한, 해수에 준해서 처방

① 咳嗽咽痛 - 초기(小青龍湯, 荊防敗毒散 등), 기침이 오래 되고 시일이 경과(六味地黃湯)

② 太陽病 誤治 - 小建中湯 加 桔梗

③ 亡陽證 - 乾薑附子湯

1) 傷寒咽痛

- 원인, 증상 및 치료

① 陽明實熱의 咽痛: 咽痛 극심, 때로 潰爛 + 發熱, 頭痛, 口乾, 口臭, 腹脹滿, 大便秘結, 小便黃赤 등 - 葛根解肌湯, 調胃承氣湯

② 寒邪가 少陰經에 침입(腎傷寒): 無表熱證, 약한 咽痛이 夜間에 甚하며 乾嘔, 吐利, 脈浮數 - 甘桔湯

③ 太陽病에 下劑나 發汗過多로 誤治: 咽喉腫痛, 心煩, 胸滿, 脈浮緊 - 小建中湯 加 桔梗

④ 發汗過多로 亡陽: 乾薑附子湯

⑤ 少陰의 陰火 上昇하여 鬱結 - 生半夏湯

⑥ 2-3일 咽痛이 있어 下利嘔逆할 때 - 甘草湯, 桔梗湯

2) 咳嗽咽痛

- 증상: 風寒, 風熱로 咳嗽 다발되어 발생한 咽痛. 風寒이나 風熱表證을 띠고 때로는 肺腎陰虛한 증상과 겸하여 발생

- 원인 및 치료

① 風寒: 荊防敗毒散加味, 蔞蘇飲, 蘇子降氣湯, 金沸草散

② 風熱: 加減薄荷煎元, 必用方甘桔湯, 金消丸

③ 咽痛 있으면서 口舌糜爛: 上清元

④ 咽喉腫痛과 大便秘結이 甚하여 大便不通: 荊黃湯

⑤ 胸中痰飲: 小青龍湯

⑥ 發汗, 發熱이 심하고 食慾減退, 氣力衰弱, 咳嗽 疼痛: 瓊玉膏, 六味地黃丸

- 허증보다는 실증 쪽의 처방을 많이 활용하게 됨

나. 만성 인두염

- 원인: 항생제 남용, 음성의 반복적 과다사용, 코막힘으로 인한 구강호흡, 만성비염으로 인한 후비루, 급성 인두염의 반복, 과도한 흡연과 음주, 자극성 가스 흡입 등

→ 만성 인두염은 선행요인이 분명하게 존재함

- 증상: 인건, 이물감, 인두 소양감, 잔기침. 심하면 인두 건조, 가피, 악취, 애성, 음성피로 등과 함께 위축성 인두염으로 진행 되기도 함. (발적 정도는 심하지 않음)

- 합병증: 난청, 후두염 병발, 표재성 림프선 종창 발생

- 종류

① 만성 단순성 인두염: 인두점막 발적, 무광택. 약간의 점막비후와 울혈된 정맥의 가지가 점막표면에 비쳐 보임

② 만성 증식성 인두염: 인두점막 전반적 발적, 점막비후. 비후가 심하면 번들거림. 목젖과 연구개점막도 비후됨

③ 만성 과립성 인두염: 인두후벽에 붉고 작은 과립이 많음. 흡연 과다 및 만성 부비동염 환자에서 흔함

④ 만성 측삭성 인두염: 선양조직이 줄기모양으로 두껍고 붉은 색을 띠면서 후구개궁을 따라 하행. 편도 절제후 흔함

⑤ 만성 위축성 인두염: 만성 위축성 비염과 동반. 인건, 불쾌감, 자극성 기침. 점막은 연한 붉은 색을 띠고 말라 보임. 표면의 진득한 점액을 억지로 떼면 혈괴 발생

1) 陰虛咽痛(虛火咽痛)

- 증상: 虛火喉痺에서 주로 발생. 咽喉에 경미한 痛痒과, 紅赤이 일어나고, 乾燥, 閉塞感, 異物感, 灼熱感이 있어서 "항", "객"하며 때로는 聲嘶도 일어나고 陰虛火旺한 症狀과 겸하여 발생 (목의 이물감을 제거하려고 힘을 주기 때문에 항이나 객하는 소리를 냄)

- 변증시치

① 陰虛咽痛: 성생활 과다 - 六味地黃湯

② 陽虛咽痛: 피로, 음성과다 사용, 항생제 남용 등 - 人蔘養榮湯, 雙和湯

③ 咽頭發赤, 痛症 甚: 清咽利膈湯 (발적이나 통증이 심하면 급증의 약을 쓰기도 함)

④ 粘稠한 분비물: 清咽潤燥湯, 清火補陰湯

⑤ 肺腎陰虛로 津液을 傷하여 虛火가 上炎: 加味四物湯, 六味地黃丸

⑥ 生鷄子湯과 鹽藕節을 兼服하고 虛火喉痺의 治療 處方 활용

인두결핵

★ 인관창에 대해 동서의학적으로 설명하시오 (03)

- 韓: 咽關瘡

- 증상: 주로 속발성. 초기에 인두가 乾燥疼痛, 점차 음식이나 물을 삼킬 수 없게 됨. 극심하면 인후가 종창되고 호흡이 촉진하고 물도 삼키지 못하게 되어 위험

- 국소 소견: 담황색의 **소결절**로 담홍색의 무리(halo)를 가지고 있고 **궤양은 표재성으로 얇고 예리한 변연**을 가지며 **저면에 과립상의 육아**가 노출. **연하통**이 심함

→ ★궤양의 국소 소견은 반드시 알아두기★

- 치료

① 초기: 甘桔湯加味, 清咽利膈湯, 加味四物湯

② 風熱: 少商, 少衝, 合谷을 男左女右로 鍼刺出血, 氷硼散을 吹入, 紫正地黃湯

③ 虛火上炎: 선 甘露飲, 후 加味四物湯, 六味地黃湯, 知柏地黃湯, 清火補陰湯

④ 熱이 極甚하고 疼痛이 있으나 胃氣는 虛弱하지 않으면: 涼膈散 加 牛蒡子

⑤ 上盛下虛로 因해 飲食無味, 中氣虛弱: 加味甘桔湯

⑥ 喉痺나 乳蛾로 因해 咽關瘡이 發生: 治喉痺生瘡方(巴豆肉, 細辛 粉末)을 鼻에 插入

⑦ 生薑 같은 辛熱 藥物은 사용 안함

<咽關瘡> 인두결핵, 매독, 인두 루푸스의 침윤, 궤양

- 瘡瘍이 인후에 발생 潰爛, 糜爛이 되는 것,

- 이명: 咽喉瘡, 咽瘡風, 痘疹咽痛

- 증상

① 초기: 인후에 乾燥, 疼痛, 腫脹, 紅黃色의 粟米狀을 띤 瘡瘍이 발생하여 점차 구강으로 파급, 또는 환처가 白頭赤根이 되고 심한 疼痛과 潰爛, 糜爛이 발생.

② 오래 진행: 紫黑色으로 변하고 腫脹, 疼痛으로 嚥下困難, 呼吸促迫, 咽喉閉塞이 되며 發熱惡寒, 煩燥欲飲, 大便秘結, 脈浮數 등이 발생

- 원인

① 風熱, 脾胃熱盛, 虛火上炎

② 痘疹, 楊梅瘡, 天疱瘡로 인해 火毒이 咽喉를 薰蒸

③ 楊梅天疱瘡의 치료에서 輕粉을 과다하게 복용하여 발생

- 치료

① 초기: 甘桔湯加味, 清咽利膈湯, 加味四物湯

② 風熱: 少商, 少衝, 合谷을 男左女右로 鍼刺出血, 氷硼散을 吹入, 紫正地黃湯

③ 虛火上炎: 선 甘露飲, 후 加味四物湯, 六味地黃湯, 知柏地黃湯, 清火補陰湯

④ 熱이 極甚하고 疼痛이 있으나 胃氣는 虛弱하지 않으면: 涼膈散 加 牛蒡子

⑤ 上盛下虛로 因해 飲食無味, 中氣虛弱: 加味甘桔湯

⑥ 喉痺나 乳蛾로 因해 咽關瘡이 發生: 治喉痺生瘡方(巴豆肉, 細辛 粉末)을 鼻에 插入

⑦ 生薑 같은 辛熱한 藥物은 사용안함

인두점막에 침윤, 궤양 유발 질환 - 참고 (결핵, 매독, 암종의 차이 알고 있어야)

★ 궤양은 표재성으로 얇고 예리한 변연을 가지며 저면에 과립상 육아가 노출되고 연하통이 심한 질환이 인두, 후두에 발생하는 경우 각각의 한방명은? (17, 13)

★ 궤양이 표재성의 얇고 예리한 변연을 가지며, 과립상 육아가 노출되고, 연하통이 심한 증상이 인후에 나타날 때 의심되는 양방명과 한방명은? (14)

★ 두진인통이라고도 불리며, 편도에 초기 경결이 보이고 침윤이 인후 및 연구개, 경구개, 편도, 비인각에 발생. 궤양이 깊고 변연이 두터우며 저면에 돼지기를 모양의 태를 형성. 동통은 적고 다소 출혈이 발생한다. 이에 해당하는 동서의학적 질환명은? (15,12,08)

★ 궤양이 깊고 변연이 두터우며 저면에 돼지기를 모양의 태를 형성하고 동통이 적고 매독이 인두, 후두에 나타났을 때 각각의 한의학적 병명은? (09)

★ 인두결핵의 ①한방병명과 ②국소부위의 특징적 소견을 쓰시오. (18,19)

1. 인두 결핵: 주로 속발성. 담황색의 소결절로 담홍색의 무리(halo)를 가지고 있고 궤양은 표재성으로 얇고 예리한 변연을 가지며 저면에 과립상의 육아가 노출. 연하통이 심함.
2. 인두 매독: 편도에 초기경결이 보이고 침윤이 인후 및 연구개, 경구개, 편도, 비인강에 발생. **궤양이 깊고 변연이 두터우며 저면에 돼지기름모양의 태를 형성, 동통은 적고** 다소의 출혈이 발생.
3. 암종: **궤양이 주위로 파급**되며 주위와 **경계가 뚜렷하지 않고** 궤양은 **분화구상**이며 접촉하면 **쉽게 출혈하고 동통이 심함**.
4. 인두 루푸스: 비성과 연하장애가 있고 때로 연구개에 **천공**이 발생. 건조한 점막에 황색이나 회백색 파종상의 **결절**이 생기고 주위에 심한 침윤이 발생하여 서서히 **반흔조직**으로 변화해서 구개가 단단해지고 인두에 변형을 유발. 안면이나 비강에서 시작하여 후두나 구강으로 파급됨.
5. 인두 헤르페스: 급성 비염, 폐염, 인플루엔자에서 수반되는 virus성 질환. 인두점막에 **일직선의 소수포**를 형성. 궤파되어 미란을 일으키며 찌르는 듯한 인두통 혹은 이통이 생기고 점액의 분비가 증가함. → 일직선 상의 수포 = 헤르페스 의심

이물경통

- 증상: 稻麥芒, 魚骨, 鷄骨, 木皮, 毛, 鍼, 기계의 파편이 인후에 誤吞되어 인후가 폐색, 중통되어 咽之不下, 吐之不出이 발생하는 것
- 이명: 誤咽食物, 誤吞異物, 穀賊
- 치료 → 실제 임상에서 쓸 일은 거의 없음
- ① 三黃涼膈散 미세분말 3錢을 燈心, 淡竹葉의 전탕액과 調服
- ② 千金葦莖湯加減
- 침구치료: 大陵穴 上 3寸의 鬼路, 즉 間使穴과 後三里 下 2寸에서 外後方 5분을 지나서 直下 2寸의 足千金穴을 한시간동안 留鍼

<서양의학> 인두이물 (foreign bodies in the pharynx)

★ 이물흡인 호발부위 3개 이상을 쓰시오 (04)

- 魚骨, 鷄骨, 毛, 木皮, 鍼 또는 기계의 파편이 주로 입을 통해, 때로는 비강, 안면, 경부를 통해 인두로 들어가는데, 대개 구역질, 기침 반사로 제거되나 이물이 크거나 예리하면 점막, 추벽 속에 자입
- **주 발생 부위: 구개편도, 인두측삭, 이상와 및 후두개곡**
- 증상: 이물감, 점막이 손상되면 인두통, 연하통, 점조한 분비물이 증가하고 큰 이물은 후두의 입구를 막아 폐색되어 호흡곤란이 되며, 또한 비인두에 이물이 오랫동안 머물게

되면 비폐색, 악취, 鼻漏의 원인이 되기도 함

- 치료는 검자로 제거, 특히 下咽頭의 이물은 내시경으로 제거

편도질환

인두, 편도질환은 대부분 풍열의 요인이 큼

- 外感邪毒이나 장부내부에서 발생된 火熱, 혹은 相火가 上炎하여 양측이나 單側의 喉核이 紅腫疼痛하고 그 형상이 마치 乳頭 혹은 乳白色의 蠶蛾와 비슷하다 하여 명명
- 咽喉間이 종대되고 폐색된다 하여 포괄적으로는 喉痺에 屬함
- 분류
- ① 急性: 急乳蛾, 鵝風, 風熱乳蛾, 飛蛾, 匣舌喉風, 奪食喉風
- ② 慢性: 陰虛乳蛾, 虛火乳蛾
- 형태에 따라
- ① 항시 종대하나 不紅不腫하는 것을 石蛾
- ② 미란이 나타나는 것을 爛乳蛾
- ③ 乳蛾가 발생되는 양상이 마치 連珠狀처럼 보인다 하여 連珠蛾
- 紅腫疼痛이 兩傍에서 일어나는 것을 雙蛾・雙鵝風
- 單傍에 있는 것은 單蛾
- 이외 風寒乳蛾, 伏寒乳蛾, 白色乳蛾 등

가. 급성 편도선염

- 韓: 傷寒乳蛾, 單乳蛾, 雙乳蛾, 風熱乳蛾
- 일반적으로 구개편도의 염증. 대부분 인두점막의 염증을 동반.
- 증상: 갑작스런 오한, 고열로 시작, 두통, 耳痛, 사지통, 인두건조감. 이후 연하곤란 및 연하통, 때로 언어장애, 구취. 중증인 경우 소변중 일과성 단백뇨가 나옴. 합병증이 없으면 1주일 안에 증상 감소.
- 편도증상: 전후 구개궁에서 편도가 중앙으로 돌출, 구개수 또는 주위 발적, 종창
- 합병증
- ① 근위 합병증: 아데노이드 설근편도 동시 염증. 확대시 편도주위농양, 인후농양, 경부림프절화농 등
- ② 원격장기에 염증을 파급시키는 병소감염: 아급성 세균성 심내막염, 급성 화농성 관절염, 급성 신염

<風熱乳蛾>

- 급성 편도선염(=angina, 口峽炎)

- 증상

① 外感邪毒이 침범하여 咽喉의 單側 혹은 양측이 작열, 홍중동통하고 腫大된 것이 乳頭狀, 蠶蛾狀 혹은 簪頭狀, 棗栗狀을 띠면서 때로는 乳白色의 白膜이 나타나기도 하며 심하면 화농이 되어 白腐한 膿液이 발생하고 동통이 극심해 呑咽不利하면서 外感風熱의 증상이 동반되는 것.

② 乳蛾, 喉蛾, 鵝風, 飛蛾라 하며 急性的으로 발생된다 하여 急蛾, 急乳蛾라고도 함.

- 원인 및 치료

① 초기 발열과 통증이 심하지 않으면 傷寒咽痛에 준하여 六味湯加減

② 風熱邪毒이 침범한 肺臟有熱

- 咽喉乾燥, 灼熱感, 喉核이 紅腫疼痛, 呑咽하거나 咳嗽가 나타나면 疼痛이 더욱 가중됨 ④ 外感風熱 증상 수반

- 치료: 荊防敗毒散, 銀翹散加減

③ 脾胃熱盛과 外感風熱이 겸한 肺脾熱盛

- 喉核의 紅腫疼痛이 극심하고 동통이 耳部 深處까지 파급되면서 喉核에 黃白色의 腐點이 일어나며 白腐한 膿液과 腐點이 융합되어서 片狀을 이루고 呑咽困難, 言語不清, 壯熱, 汗出, 面赤脣紅, 口渴, 口臭 등의 증상을 수반

- 치료: 清咽利膈湯加減, 普濟消毒飲, 神仙活命飲 등

④ 外治

- 冰硼散, 珠黃散, 錫類散을 吹藥

- 解毒, 消腫, 止痛이 있는 連翹, 荊芥, 牛蒡子, 菊花, 薄荷, 明礬, 硼砂로 含漱

- 예방: 山豆根, 生橄欖, 蘿菈를 水煎하여 항상 복용 → 병을 완화 또는 피함.

→ 인후의 병 예방하려면 무를 많이 먹으면 좋음

⑤ 鍼灸治療

- 合谷, 內庭, 曲池, 天突, 少澤, 魚際, 孔最, 足三里, 照海, 內庭, 風府, 頰車, 廉泉穴을 刺鍼

- 少商, 商陽穴과 金津, 玉液, 耳背의 小靜脈을 三稜鍼으로 자주 瀉血

- 發熱, 疼痛, 呑咽困難이 극심하면 喉核 紅腫 부위를 長鍼이나 주사기로 鍼刺出血

⑥ 관리: 안정과 충분한 수분섭취, 가벼운 식사가 필요

六味湯(육미탕) → 형방패독산 구성과 유사. 증상이 심하지 않을 때 널리 사용 가능

- 구성: 薄荷, 荊芥穗 각 3錢, 防風, 桔梗, 生甘草, 白殭蠶 각 2錢

- 주치: 喉科七十二症. 急喉瘡, 卒然 聲音不揚, 甚則嘶啞, 或兼有咽喉微痛, 呑咽不利, 喉痒, 咳嗽不爽, 鼻塞流涕, 惡寒發熱, 頭痛无汗, 苔薄白, 脈浮緊

나. 만성 편도선염

- 韓: 虛火乳蛾, 陰虛乳蛾, 伏寒乳蛾

- 소아: 계속되는 상기도의 감염으로 아데노이드와 더불어 심한 증식증을 보여 기계적인 폐색유발.

- 성인: 크기가 위축되는 섬유성 편도염

- 증상: 만성적. 대개 만성 인두염과 병발

① 완화기: 대개 무증상이나 경도의 인두통, 이물감, 기침, 구취

② 편도 비대기: 연하곤란, 비 및 구호흡 장애

③ 전신증상 (세균, 독소의 혈관 유입): 영양불량, 병소감염(심장 등)

- 만성 편도선염의 국소소견: 전후 구개궁에서 두드러져 나와 생리적 혹은 병리적 **비대** 상태. 편도의 **표면은 울퉁불퉁**하고 **주위조직과 유착**되며 전구개궁을 누르면 음와에서 **고름**이 나올수 있음. → 만성은 일단 비대되어 있음. 표면은 울퉁불퉁하고

- 치료

① 陰虛乳蛾: 扁桃腫大가 있고 통증은 아침에 가볍다가 오후 및 밤으로 점차 심해짐. 八味地黃湯, 養陰清肺湯

② 伏寒乳蛾: 咽喉痛이 있으나 紅腫하지 않고 紫色을 띠며 脈細數, 혹 沈遲. 六味湯加味

- 급성 및 만성편도선염의 치료: 안정과 輕食, 항생제 사용, 생리식염수나 2% 重曹水로 含漱시켜 인후를 청결.

<陰虛乳蛾>

- 만성 편도선염, 비대, 편도주위농양과 유사

- 증상

① 肺腎陰虛로 虛火上炎되어 발생. 반복적, 만성적인 乳蛾.

② 홍중동통은 극심하지는 않으나 咽喉 乾燥不快, 微痛微痒하고 喉核에 乳蛾가 비대하며 동통은 아침에는 輕하고 오후가 되면 심해졌다가 밤에는 더욱 심해짐.

③ 虛火乳蛾, 石蛾, 死乳蛾核, 活乳蛾核, 乳蛾核.

- 원인 및 치료

① 肺陰虧虛

- 원인: 邪熱이 未清되어 邪熱이 肺陰을 손상
- 증상: 咽喉乾燥不快, 喉核潮紅肥大, 有微星點, 咳嗽, 無痰 或 少痰, 粘稠, 口乾舌燥, 煩熱
- 치료: 養陰清肺湯, 甘露飲, 益氣清金湯
- ② 腎陰虛損
- 원인: 房勞過度로 腎陰을 傷하여 虛火上炎
- 치료: 陰虛火旺과 兼하면 知柏地黃湯, 石蠟(桔梗湯加味), 心脾積熱과 酒毒이 蒸하여 咽喉에 熱이 壅塞(鼠粘子解毒湯, 涼膈散加減)

편도가 커져있으면 소금물로 입안을 행구는 것이 도움이 됨

→ 목적은 커져있는 편도를 위축시키는 것

편도 주위 농양

- 韓: 爛乳蛾, 連珠蛾
- 원인: 구개편도의 급성적인 염증이 피막을 통하여 주위결체조직에 파급될 때에 발생. 편측성으로 농양 형성. 편도상극에 호발
- 증상: 급성 편도선염의 증상과 유사. 편측에 격렬한 통증 발생, 점차 耳 및 頸部로 방산되며 연하통 및 연하곤란도 증가. 특히 익상근 부위까지 파급되면 開口가 곤란하게 되어 특이한 構音障礙 발생.
- ① 연하통(귀에서 목까지 전달되는 동통), 고열, 구취, 두통, 타액분비과다, 식욕감퇴
- ② 구개편도 주위의 발적 종창(전구개궁부 혹은 후구개궁부)으로 구개편도 포용형상
- ③ 환측 연구개의 하수, 구개수의 부종으로 건측으로 압박.
- 치료
- ① 熱毒 심화: 六味湯, 清咽利膈湯 등
- ② 少商, 商陽穴을 자침출혈
- ③ 농양형성 전에는 대증요법이나 항생제를 사용. 농양 형성되면 절개배농 시키면서 항생제 사용

인두편도 비대증

- 인두편도는 원래 5~10세에서 발육이 가장 좋으며 사춘기 이후에는 생리적으로 위축되거나 또는 완전히 소실.
- 원인: ① 급성 염증의 반복 ② 비강, 부비동의 만성염증
- 증상: 인두편도의 증식으로 협소한 비강을 폐색하게 되어 늘 鼻閉塞으로 비호흡이 되지

않고 비분비물의 배설장애도 일어나서 더욱 증상을 악화시키며 항시 口呼吸으로 입이 반쯤 열려져 우둔한 인상과 上顎前齒가 돌출된 특이한 **Adenoid face**가 나타난다. 또한 이관이 폐색되면 청력장애와 耳鳴도 일어나며 염증이 비강, 부비동, 중이, 유양돌기, 후두, 기관 및 기관지로 파급되기도 한다.

- 진단: 전비경검사(인두편도의 비대), 후비경검사(증식된 adenoid), 측진(소아에서)
- 치료: 수술(대개 4~10세 이하 시행)

구개편도 및 아데노이드 절제술 - 참고

- 적응증

- ① 반복되는 염증
 - ② 편도주위농양
 - ③ 기계적인 폐색을 일으킬 정도로 비후
 - ④ 디프테리아균 보균자
 - ⑤ 반복되는 중이염
 - ⑥ 비후된 편도 및 아데노이드로 인한 장액성 중이염으로 청력소실 우려
 - ⑦ 경부 림프선이 계속하여 커져 있을 때
 - ⑧ 관절염, 류머티즘열, 천식의 악화 등이 편도염과 확실한 관계가 있을 때
- 금기증

- ① 모든 종류의 급성 염증, 특히 상기도의 급성 염증
- ② 혈우병, 백혈병, 자반증 또는 고도의 빈혈이 있을 때
- ③ 당뇨가 있을 때
- ④ 심장병 또는 신장염이 있을 때 → 인후파트에서는 심장, 신장으로 침범하기 때문
- ⑤ 활동성 폐결핵이 있을 때
- ⑥ 고령자 또는 고혈압환자
- ⑦ 소아마비의 유행 시기

02 후두질환

급성 후두염

- 원인: 주로 바이러스, 연쇄상구균, 폐렴균 등의 세균감염. 혹은 화학약품, 담배 등의 자극, 건조한 공기 및 성대의 남용으로 발생
- 증상: 애성이 주증상. 성대 부종이 심해지면 실성, 흡기성 천명 발생. 기침, 인후부 건조감, 통증, 이물감, 말을 많이 하면 증상 더 심해짐. 38°C의 발열 동반. → 애성 = 쉼 목소리
- 변증시치
 - ① 발열, 기침, 통증이 있는 경우 안정 필요
 - ② 휴식과 충분한 수분섭취가 가장 중요
 - ③ 성대 보호를 위해 음성남용을 막고 실내의 온도 습도 조절
 - ④ 六味湯 가감

(여기서부터는 환자가 금방 악화되는 응급질환에 해당. 교수님도 실제로 본적은 없으심)

급성 후두기관지염

- ★ 5세 이하의 소아에서 겨울철에 다발하고 초기에는 단순한 상기도 감염 증상과 39~40°C의 고열을 동반하고, 2~3일 후부터 ~ 거친 기침(barking cough), 호흡곤란, 구토, 저산소증, 청색증 등을 일으키는 경우 의심할 수 있는 서의학적 질환은? (18,13,11)
- 5세 이하의 소아, 특히 남아에 다발.
- 후두, 기관 및 기관지에 심한 급성 염증을 일으키는 것으로 겨울에 자주 발생.
- 크루프(croup)의 대표적 질환으로 흡기성 천명, 거친 기침(barking cough), 목쉼소리(hoarsness) 등을 동반.
- 원인: 대부분 Virus에 의한.
- 병리: 성문하부의 부종성 종창으로 기도폐쇄와 점차 아래로 내려가 기관, 기관지 점막의 종창을 일으킴.
- 증상: 초기에는 단순한 상기도 감염 증상과 39~40°C의 高熱을 동반하고, 2~3일 후부터 특징적인 흡기성 천명, 거친 기침(밤에 주로 시작)을 동반하면서 호흡곤란, 구토, 저산소증, 청색증 등 일으킴.
- 치료: 차가운 증기로 포화된 조건하에서 수액, 항생제, 산소 등을 투여. 심한 부종으로 인한 호흡곤란시 기관절개술 시행.

급성 후두개염

- ★ 6-7세 소아가 갑자기 갑자기 40°C의 고열과 연하장애, 호흡곤란을 일으키고 ~ 후두개는 구형으로 종대되어 있음. 서양의학적 질환명은? (19,14,12,09,08)
- ★ 급성 후두개염 증상과 한방명 (04)
- 6~7세 이하의 소아에 다발. 후두개의 봉와직염. 점막은 적색, 심하게 종창되어 호흡장애 초래.
- 원인: 세균 또는 Virus에 의한 원발성 후두개 국한성 염증, 또는 급성 인두염으로 인해 염증이 후두에 파급, 심한 화농성의 염증이 점막하에 파급, 연골막염이 합병되어 발생.
- 증상: 갑자기 40°C의 高熱과 연하장애, 호흡곤란을 일으키고 짧은 시간내에 악화되어서 청색증에 빠짐. 호흡곤란으로 환자는 앓아 있으려 하고 입을 벌리며 목쉼 소리는 없으나 가려진 목소리(muffled voice)를 내고 인두와 후두점막, 설편도에 발적과 종창을 보임. 특히 후두개에 국한된 심한 발적과 종창이 나타나고 후두개는 球型으로 종대되어 있음.
- 후두개가 열리면서 공기가 통해야하는데, 이게 막혀있다고 생각하면 됨
- 진단: 후두개의 舌面에서의 발적 및 종창, 설근부의 종창, 심한 연하통, 경부의 측면 X-선에서 성문상부의 종창을 볼 수 있음.
- 치료: 적절한 항생제 투여. 기관절개 할 필요는 없으나 호흡곤란이 심하면 즉시 실행.

曰: 봉와직염 감별하는 법

- 무릎 관절~발목까지 다리가 많이 부은 환자가 왔다면
- 체크: 상처의 유무 파악, 상처가 없다면 발쪽에 무좀이 있는가? (발바닥이 갈라져 세균 감염 可)
- 상처가 있었고 2~3일 지나면서 염증, 홍종열통이 나타나면 봉와직염을 의심!
- 치료: 항생제를 가장 강한 것으로 사용 (절단해야 할수도 있기 때문)
- 한방치료: 위기영혈변증에서 영분 or 혈분 사용
- 봉와직염으로 보이면 병원으로 보내서 항생제 + 수액

급성 경련성 후두염

- 원인: 불명. 가벼운 상기도염이나 정신적 요인이 관여
- 4세 이하의 남아에서 호발
- 증상: 수면 중 발작적인 거친 기침, 흡기성 천명, 호흡곤란으로 흥분 불안 공포 상태 발생. 심하면 의식상실, 청색증 유발. 잠시 후 구토하면서 정상상태로 수면 취함.
- 치료: 별무치료. 평상시 습도를 높여주는 것이 좋음

후두 디프테리아

- 韓: 白喉
- 원인: 디프테리아균에 의해 발생. 6세 이하 소아에서 호발. 인두 디프테리아에서 속발
- 증상: 초기 1주일 내외의 잠복기 후에 인두통, 오한, 발열이 발생하다가 후두에 파급되어 嘔聲과 犬吠樣 咳嗽 발생.
 - ① 嘔聲: 건조 및 협착성으로 나중에는 無聲까지 이르고 위막 형성 및 종창에 의해 얼굴 창백, 冷汗, 흡기성 호흡곤란, 천명이 증가되어 경련 발생.
 - ② 위막: 후두개의 내면 성대부와 후두내강에서 황색, 회백색을 띠며 제거하면 출혈 발생.
- 치료: 디프테리아에 대한 치료

만성 단순성 후두염

- 원인: 내부요인(흡연, 부비동염, 역류성 식도염 등), 외부자극(음성 남용, 먼지 자극, 매연, 담배연기 등) → 최근 추세는 매핵기를 위장, 식도 관련 문제로 봄
- 증상: 시간에 따른 음성 변화가 주증상. 때로 지나친 성대 피로로 인해 무성. 만성적인 후두 이물감, 건조감, 소양감, 잔기침 등 호소. 연하장애나 동통은 없음.
- 후두경상 후두점막 충혈(암적색, 핑크색), 성대 광택 소실, 작은 혈관들이 성대방향과 평행하게 주행
- 치료: 자극 원인 제거. 생활습관 개선. 발성 재교육, 적당한 습도 유지.

위축성 후두염

- 韓: 臭鼻症 연장. 喉癰 일부
- 원인: 불명. 후두부위 방사선요법, 만성 단순성 후두염, Sjörgen 증후군 일부, 임신 등
- 여자에서 빈번, 위축성 비염 동반
- 증상: 점액 분비 및 점막유허의 감소로 계속적인 목의 건조감 호소. 가벼운 기침, 심한 구취. 심한 기침으로 후두 가피 탈락으로 객혈, 호흡곤란 유발하기도 함.
- 후두경상 건조하고 거친 후두점막, 작고 진한 점액성 분비물, 피열간부에 가피가 있고 가피를 떼면 삼출표면을 보이나 실질적인 미란은 없음.
- 치료: 점액선의 부분 또는 완전한 파괴로 완치 어려움. 대증요법 시행

喉痺 후비

《素問·陰陽別論》"一陰一陽結，謂之喉痺" → 心包三焦經 火氣內結 泄熱散結爲主
《素問玄機原病武》"喉痺，痺 不仁也。俗作閉，猶閉塞也"

→ 한마디로 폐색

- 喉痺는 喉內가 폐색되어 호흡불통, 언어불출, 인후종통 및 궤란, 연하곤란이 발생하는 咽喉疾患의 증후
- 후비의 개념
 - ① 광의의 후비: 서양의학의 편도 및 인후부의 종양, 인후의 염증 및 전염성 질환에 해당되는 乳蛾, 喉癰, 白喉와 여러 종류의 喉痺 → 여러 질환에 해당함
 - ② 협의의 후비: 인후가 발적, 홍종동통, 건조, 소양 및 불쾌하여 咽喉不利되는 것으로 서양의학의 단순성 및 비후성 인두염과 유사
- 종류: 風熱喉痺, 風毒喉痺, 傷寒喉痺, 白色喉痺, 酒毒喉痺, 爛喉痺, 單喉痺, 雙喉痺, 陰毒喉痺, 走馬喉痺, 寒伏喉痺, 天行喉痺 등

1) 外感에 의한 喉痺

- 風熱喉痺, 風毒喉痺, 傷寒喉痺, 白色喉痺, 天行喉痺 등
- 白色喉痺: 디프테리아에 의한 인두 위막 형성
- 天行喉痺: 급성 전염성 질환에서의 인후두염
- 치료: 경증(荊防敗毒散), 중증(清咽利膈湯, 普濟消毒飲 등)

2) 酒毒喉痺

- 원인: 과다한 음주로 인한 心脾二經의 酒毒
- 증상: 심한 발열 상태. 인후 熱鬱, 腫大되고 황색을 띠며 얼굴 홍적색이 나타나고 眼睛이 위로 되며 發熱, 惡寒, 頭痛, 項強
- 치료: 먼저 桐油로 痰涎을 토하게 하고 鼠黏 子湯 투여

3) 陰毒喉痺 → 이렇게 있다 정도만

- 원인: 추운 겨울에 습기가 몸에 침입한 상태에서 火邪가 작용
- 증상: 인후 종대, 오한, 근육 떨림, 요통, 脚冷. 악화되면 환처가 紫黑, 堅硬해짐
- 치료: 먼저 五福化毒丹 투여 후 蘇子降氣湯 사용.

4) 走馬喉痺

- 매우 급성적으로 진행
- 원인: 肝脾의 火
- 증상: 咽喉와 頤部가 동시에 腫大. 病毒이 왕성하여 병이 급진적으로 진행
- 치료: 六味湯加味. 少商, 商陽, 關衝 등을 鍼刺出血.

참고

가. 風熱喉痺

- 증상

① 肺經有熱: 초기 風熱表證 ⊕ 咽喉微紅腫, 疼痛灼熱, 乾燥感, 閉塞感, 咽痒, 咳嗽痰多, 吞咽不利

② 肺胃熱盛: 紅腫疼痛이 극심, 吞咽困難, 痰多粘稠, 高熱, 頭痛, 口乾

- 원인 및 치료

① 風熱邪毒으로 인한 肺經蘊熱: 荊防敗毒散, 銀翹散, 疏風清熱湯

② 肺胃熱盛: 清咽利膈湯, 五味消毒飲, 甘露消毒飲, 玄參煎, 蘇子降氣湯

- 돌발적으로 홍중동통이 극심하고 喉閉, 痰多粘稠, 吞咽不利 - 解毒雄黃元로 涌吐, 牛黃涼膈元을 薄荷煎液과 調服

- 만성적으로 熱毒이나 邪熱이 肺津을 손상시켜 陰虛火旺과 겸 - 六味地黃湯加味

- 상한병으로 인한 喉痺: 甘桔湯, 半夏甘草桂枝湯

- 外治: 氷片散, 紫雪散, 膽礬散, 備急丹을 吹藥, 蜜炮 附子를 含咽, 薄荷, 羌活 板藍根을 水煎하여 수차례 含漱

- 鍼灸治療: 少商, 商陽, 關沖穴을 鍼刺出血

- 서양의학: 급성 인두염 (① 급성 인두축삭염 ② 급성 과립성 인두염 ③ 구개수염 등으로 분류)

나. 虛火喉痺

- 증상: 肺腎陰虛로 인해 虛火가 上炎되어 咽喉乾燥, 微紅腫, 微痛痒, 乾咳少痰, 異物感이 나타나는 것

- 이명: 陰虛, 陽虛, 格陽喉痺

- 喉底에 氣子狀과 같은 것이 많으면서 과립이 겹쳐 연결되어 片狀을 이루는 것을 簾珠喉, 簾珠喉痺라 하는데 이것도 虛火喉痺에 屬한다.

- 원인 및 치료

① 肺陰不足: 清燥救肺湯, 沙蔘麥門冬湯, 百合固金湯, 養陰利咽湯, 加味四物湯, 甘露飲

② 肝腎陰虛: 知柏地黃湯加減, 附桂八味丸, 右歸飲 또는 杞菊地黃丸에 玄參, 桔梗을 加

③ 心火亢盛: 黃連阿膠湯에 熟地黃, 山藥을 加

- 外治: 氷片散, 氷硼散, 鹽礬散을 吹入, 蜜炮 附子를 數次 含咽

- 서양의학: 만성 인두염 (① 만성 단순성 인두염 ② 만성 증식성 인두염 ③ 위축성 인두염 등으로 분류)

★ 5세 남자아이가 갑자기 호흡곤란, 연하곤란, 고열 등이 있어 내원하였다. ~ 국한된 종창이 보였는데 만지면 유연한 파동을 촉진할 수 있었다. 의심되는 한방병명 및 양방병명은? (02, 15)

다. 走馬喉痺 → 走馬 = 예후가 불량. 급성으로 진행

- 증상: 喉痺가 돌발적 발생, 인후 및 경항부까지 홍중동통이 파급되어 폐색. 발병도 매우 급속하여 그 기세가 마치 말이 달리는 것과 같다 하여 또는 홀연히 인후가 폐쇄되어 사망하게 된다 하여 猛疽, 急喉痺, 急喉閉라 함.

- 포괄적으로는 喉閉, 喉癰, 喉風에 屬함.

- 원인: 肺胃熱盛, 肝膽이나 脾胃의 熱盛으로 火毒이 咽喉에 結聚되어 발생

- 침구치료: 먼저 少商, 關衝, 商陽穴을 鍼刺出血

- 외치: 一字散, 二仙散, 奪命散, 金鎖匙를 粉末하여 吹藥, 龍腦破毒散을 膏로 만들어 含咽

- 내치: 六味地黃湯에 葛根, 柴胡, 細辛, 皂 角刺, 當歸尾, 赤芍藥을 加

- 서양의학: 인후농양, 小兒에서 급성적으로 발생하는 후두개염, 경련성 후두염과 후두부종

인후농양

★ 유, 소아에서 갑자기 호흡곤란, 연하곤란, 발열이 있으면서 인두에서 거품을 동반한 분비물과 편측의 인두후벽에서의 통증, 만졌을 때 파동이 느껴질 때의 병명은? (18)

- 인두에 농양이 생기는 대표적인 질환. 대부분이 급성적인 중증의 인두질환

- 인후농양은 인두후간극에서 림파절의 화농이 인두수축근과 척추전막사이에서 형성되고 특히 유.소아에서 많으며 진단이 늦어져서 치료가 부적절하면 생명이 위험하다.

- 성인에서 극히 적으나 최근에는 드물게 성인에서도 결핵성의 만성 농양, 당뇨병에서 합병

- 전신증상: 환자는 불안해하고 창백하며 급격히 체온이 상승. 농양이 형성되면 연하곤란, 연하통, 비폐색으로 인하여 포유 곤란하고 음성은 입안에 물건을 물고 하는 것과 같음. 두부는 신장, 흡기성 및 호기성천명 발생. 농양이 커져서 후두 입구부를 압박하면 호흡곤란을 초래함.

- 진단: 유, 소아에서 갑자기 호흡곤란, 연하곤란, 고열 등이 있고, 인두에 다량의 거품이

섞인 분비물과 편측의 인두후벽에 국한된 종창이 보이며 만져서 파동을 느끼면 의심 가능

喉風 후풍

- 돌연적으로 인후가 종대되어 閉塞腫痛하며 호흡이 곤란하고 痰涎이 응성하며 음성이 애성이 되면서 말이 잘 나오지 않고 극심하면 頸項 表面까지 파급되어 紅腫되는 질환
- 후비를 포함하는 조금 더 큰 범위라고 생각하면 됨. 후풍은 경항부까지 파급
- 종류: 纏喉風, 啞喉風, 鎖喉風, 緊喉風, 慢喉風, 勞役喉風, 酒毒喉風, 腫爛喉風, 肺寒喉風, 白色喉風, 紫色喉風, 陰虛喉風, 弄舌喉風 등
- 內因: 肺胃積熱, 脾失健運
- 外因: 風熱疫毒
- 변증론치
- ① 急性: 痰涎 왕성시 먼저 구토하게 한 후 약물로 치료. 六味湯
- ② 慢性: 苦蔘湯, 補中益氣湯加味
- ③ 外感: 六味湯에 羌活, 蘇葉, 當歸, 柴胡, 牛蒡子, 桂枝, 細辛 등 가미
- ④ 陰虛: 生地黃湯
- 서양의학: 소아의 급성 후두개염, 경련성 후두염, 후두부종, 급성 후두기관지염, 인후부종양의 증상과 비슷.

★ 후비와 후풍을 감별하시오 (02,03,19)

喉痺와 喉風の 감별

- 喉痺: 喉里腫痛, 甚則閉塞不通, 水漿不入, 語不能出. → 폐색. 인두나 후두에 국한
- 喉風: 哮聲如鋸拽, 甚則牙關拘急, 神志不清.
- 거친소리, 입을 벌릴 수 없고, 의식 떨어짐. 경항부까지 파급

★ 전후풍, 급후풍, 쇠후풍을 구별 (00,09,10)

참고 - 후풍의 3가지

1) 纏喉風

- 증상
- ① 급성적으로 인후에 홍종동통이 극심하고 천명, 호흡곤란, 언어난출, 呑咽困難, 水漿不入이 나타나면서 頸項強直이甚하며 喉內에 마치 뱀이 감은 것 같은 紅絲가 얹혀 있는 蛇纏狀을 띠는 것으로 속히 치료하지 않으면 사망.
- ② 急喉風, 緊喉風, 啞喉風 또는 啞瘡 喉風과 증상이 비슷
- 원인
- ① 實證: 時氣邪毒, 風溫邪毒이 肺胃에 침범
- ② 虛證: 忿怒失常으로 肝火가, 痰熱 혹은 飲酒過度로 胃火가, 房勞過多로 腎火가 動하여 痰熱이 燔灼되어 발생
- ③ 이외 咽喉癰, 頤 下癰, 急性 膿耳, 骨梗損傷, 外傷感染毒으로 인해 頸部에서 邪毒이 침입
- 치료
- ① 먼저 巴豆烟을 훈증하거나 雄黃散을 吹入하여 涌吐시킴
- ② 冰麝散, 佛手散, 一字散으로 吹藥하고 白礬散과 艾葉, 蒲公英으로 含漱
- ③ 처방: 解毒雄黃元, 龍腦破毒丹, 清咽利膈湯加減, 三黃涼膈散, 清瘟解毒飲
- ④ 침구치료: 양측의 頰車, 少商, 關衝, 少衝, 商陽穴을 刺鍼하나 留鍼시키지 말고, 少商, 商陽穴은 瀉血하며, 合谷, 尺澤, 少澤, 曲池, 天鼎, 扶突穴 등을 병행하여 사용

2) 急喉風 : 소아의 급성 후두개염의 증상

- 증상
- ① 홀연히 인후가 홍종동통하고 폐색되어서 痰涎壅盛, 喘鳴, 水漿不入, 飲食不能, 언어 및 호흡곤란이 나타나는 것으로 喉緊, 緊喉風 또는 酒毒喉風이라 한다.
- ② 홍종동통이 극심하면서 발병이 매우 급히 일어나는 점에서 纏喉風, 鎖喉風과 유사
- 纏喉風과 감별: 急喉風은 喉內에 蛇纏狀, 즉 마치 뱀이 감은 것 같은 紅絲가 얹혀 있지 않고 홍종동통이 극심하며 인후가 폐색.
- 鎖喉風과 감별: 鎖喉風은 紅腫이 頸項頤 頰部로 파급되지 않고 심할 경우에는 牙關緊急, 口噤 이 나타나서 纏喉風, 緊喉風이 진행된 증상.
- 원인: 纏喉風 참조
- 치료
- ① 喉間의 紅腫疼痛된 부위를 사혈하여 惡血을 제거, 少商과 委中穴을 放血

- ② 水礪散, 神效吹喉散을 吹入
- ③ 내복: 清咽利膈湯, 甘桔湯加減, 麻杏甘石湯加味, 清咽散, 六味地黃湯加味.
- ④ 이외 纏喉風의 치료를 활용

3) 鎖喉風

- 증상

① 急喉風, 纏喉風과 증상이 비슷. 喉內的 종대가 극심하여 痰涎壅盛, 水漿不入과 언어 및 호흡곤란이 발생되나 鎖喉風은 **홍증이 頸項頤 頰部로 파급되지 않고** 심할 경우에는 **牙關 緊急, 口噤**이 나타남. → 쇄후풍은 전후풍, 급후풍이 더 진행되어 위중한 상태. 근데 후풍의 양상인 경항부 파급은 나타나지 않음

② 纏喉風, 急喉風(緊喉風)이 진행된 증상

- 원인

- ① 外感風熱이나 時氣邪毒, 瘟疫邪가 肺胃에 침범
- ② 痰火가 인후에 결취
- ③ 熱毒이 치성되어 風이 動하여 경맥에 침범
- ④ 이외 급성적인 인후병, 喉癰, 소아의 喉疳 및 白喉가 발전

- 치료

- ① 내복: 三黃涼膈散, 三黃湯, 甘桔湯, 清咽湯, 二陳湯加減
- ② 외치: 紫金丹, 淡薑湯을 갈아서 灌水入, 通關散으로 吹鼻하여 개구시킴
- ③ 침구치료: 환처 홍중부를 다량 出血시켜 惡血을 제거. 少商, 商陽穴을 刺鍼出血. 양측 少商, 商陽, 關衝, 曲池, 合谷, 扶突, 尺澤, 陷谷, 風門穴을 刺鍼.
- ④ 이외 纏喉風, 緊喉風의 치료를 활용.

4) 淡紅喉風

- 증상: 인후종대로 閉塞不通되고 불래 및 건조감, 聲音不清 ⊕ 風熱表證 발생

- 원인 및 치료: 外感風寒, 風熱, 肺胃熱盛 - 升麻石膏湯, 清咽利膈湯, 荊防敗毒散加減, 六味地黃湯加味

5) 陰虛喉風 - 虛爛喉風, 腫爛喉風

- 증상: 喉內에 斑點, 斑癍, 潰爛이 발생하거나 蝦皮狀을 띠면서 발열, 해수가 동반, 六脈細數하고 심할 경우에는 嘎聲

- 원인 및 치료: 肺腎虛損 虛火上炎 - 玄蔘生地湯, 清火補陰湯, 補陰湯加減, 六味地黃湯

6) 酒寒喉風

- 증상

① 酒寒: 인후가 종대되지는 않으나 동통이 일어나고 淡紅色의 顆粒이 나타나며 六脈 洪大.

② 酒毒: 喉關이 홍중동통, 痰盛, 飲食不入하며, 때로 肺脈 遲 혹은 兩關脈 大

- 원인 및 치료: 음주과다 후에 寒冷이 침범되거나 肺胃寒冷으로 발생

① 酒寒: 六味地黃湯 加天花粉, 枳棋子, 黃芩, 葛根.

② 酒毒: 六味地黃湯 加生甘草, 葛根, 海浮石, 枳棋子, 山梔子, 生地黃, 牡丹皮

03 성음 및 언어장애질환

- 음성은 五臟의 기능에서 이루어지며 喉는 肺의 外竅로 호흡의 門戶이고 발성의 機關이므로 肺氣가 음성을 발하는 작용이 있으며 그 근본은 腎主納氣로 腎에 있고 心神의 작용으로 心에서 언어를 주관한다.

- 성음병의 종류 중

① 失音 혹은 瘖症, 聲啞: 전혀 발음을 하지 못하는 發聲不出

② 聲嘶 혹은 音啞: 음성이 청아하지 못하고 沈濁한 破聲

- 언어장애와 실어증의 구분

① 言語障礙: 발성기능의 병변으로 언어 산출에 장애가 되는 것. 즉, 폐·기관·기관지와 같은 호흡기관과 후두·성대와 같은 발성기관 및 조음기관인 입술·비강·구강의 장애로 발생되는 말장애

② 失語症: 언어를 구사하고 이해하는데 관계되는 중추신경계 손상으로 발생하는 것

<서양의학>

- 대부분 좌반구가 언어를 담당하는 주반구임.

① 대뇌반구의 표면에 울퉁불퉁하게 튀어나온 腦回轉(gyrus)과 움푹 패인 溝(sulcus)를 角回(Brodmanns Area Nos. 39)라 하는데 이곳은 written language를 담당.

② 상부 측두엽의 뒷쪽 1/3을 차지하는 베르니케 부위(Brodmann Area Nos. 41, 42)가 구사, 즉 spoken language를 담당.

③ 하위 전두엽의 뒤쪽 끝에 위치한 브로카 부위(Brodmanns Area Nos. 44)는 motor aspects of speech의 기능을 담당.

각회, 베르니케, 브로카

- 각회: 눈에 대한 시각적 입력이 일차적으로 시각영역에 전달되고 그 다음에 각회로 중계됨. 병변시 실독증, 실서증, 전도성 실어증 발생

- 베르니케: 청각부호들과 단어들의 의미가 저장되어 있는 곳. 병변시 말은 유창하나 의미와 내용이 없는 착어증, 감각성 실어증

- 브로카: 한 단어를 발성하는데 요구 되어지는 근육활동들의 순서를 규정해주는 발성부호들을 저장하고 있는 곳. 병변시 단어를 정확히 발음하기 어려우며 느리고 힘들게 말을 하며 단지 핵심 단어들만 포함하는 표현성 실어증

音啞 음아

가. 風熱音啞(急音啞): 급성 후두염 및 성대마비, 성대염

- 급성적으로 嘎聲 혹은 聲嘶가 되고 심하면 失音이 되는 金實無聲 → 실증의 외부사기

- 이명: 暴瘡, 暴啞, 瘖瘡, 卒然無音, 急喉瘖, 猝啞, 聲嘶

- 증상

① 風寒: 돌연히 성음이 不暢되고 심하면 嘶啞失音이 되며 喉中이 건조불쾌, 微痛, 微紅腫, 이물 및 소양감 ④ 聲重, 오한발열, 두통, 鼻塞涕涕, 無汗

② 風熱, 胃熱: 홍종동통, 작열감으로 呑咽困難이 되고, 성음이 粗粗하여 音底되면서 嘶啞失音

④ 痰盛粘稠, 壯熱, 煩燥, 鼻塞, 口臭

- 원인: 風寒, 風熱邪가 肺經에 침입하거나 혹은 肺胃積熱, 氣血凝滯.

- 치료

① 風寒: 荊防敗毒散, 蔞蘇飲, 荊蘇湯, 人蔞荊芥散, 甘桔湯, 三拗湯加味

② 風熱: 秘傳降氣湯, 清咽利膈湯, 疏風清熱湯, 人蔞瀉肺湯, 麥門冬湯

③ 胃熱: 竹葉石膏湯

④ 肝膽火熱: 紫胡清肝散

⑤ 火熱로 肺津이 손상: 四陰煎, 桑杏湯加減

⑥ 大寒으로 腎傷寒, 또는 久病, 大病 후의 聲啞失音: 生脈散合異功散, 六味, 八味地黃元, 大補元煎, 腎氣丸加減, 麻黃附子細辛湯

⑦ 燥熱로 痰 壅盛하여 失音, 聲音不出: 芎藭散

⑧ 喉痺로 인해 聲嘶失音: 通關飲, 通隘散, 增損如聖湯, 秘傳降氣湯加減

⑨ 號叫, 歌唱, 悲哭으로 喉破가 된 聲啞失音: 生脈散, 十全大補湯加味

나. 陰虛音啞(慢音啞): 만성 후두염 및 성대염, 성대마비, 후두염

- 증상: 점차적으로 嘎聲 혹은 聲嘶가 발생되고 심하면 失音이 되는 金破無聲

- 이명: 久喑, 聲啞, 喑啞, 陰虛音啞, 久病失音, 喉痺失音

① 肺腎陰虛: 聲嘶가 오랫동안 나타나고 성음이 低啞, 乾枯가 되며 인후가 건조, 燥熱, 微痛, 乾咳, 痰少稠粘, ④ 陰虛內熱한 증상

② 肺脾氣虛: 聲嘶는 노권이나 한냉한 약물 혹은 음식을 복용하면 더욱 심해지고 성음이 피로감 및 低下되며 ④ 氣虛한 증상(面萎黃, 倦怠無力, 口淡不渴, 易感冒)

③ 氣滯血瘀: 인후에 阻塞 및 이물감, 소양감이 나타나고 痰稠, 舌質紅, 苔少, 脈細數

- 원인 및 치료

① 肺腎陰虛: 人蔘固本丸, 天真丸, 百合固金湯, 左歸丸, 右歸丸, 人蔘平肺湯, 大補元煎, 六味地黃丸, 大補陰丸, 瓊玉膏加減, 附桂八味丸加味, 生脈散加減

② 肺脾氣虛: 歸脾湯, 理陰煎, 補中益氣湯, 補陰益氣煎

③ 氣滯血瘀: 桃紅四物湯合二陳湯에 枳實, 牡蠣를 加

- 外治로 肺腎陰虛(薄荷, 桑葉, 菊花, 蘆根, 生地黃, 玄蔘), 肺脾氣虛(荊芥, 紫蘇葉, 細辛, 香薷, 石菖蒲, 訶子, 桂枝), 氣滯血瘀(靑皮, 川芎, 澤蘭, 蓬朮, 白芥子, 半夏, 竹茹, 烏梅, 海藻)를 口鼻로 熏蒸. → 후두 쪽은 약을 먹는 것보다는 증기를 흡입하는게 더 도움이 됨

- 변증론치 (급성과 만성 모두 포함)

1) 風熱音啞: 蟬衣散, 礪砂丸

2) 성생활과다: 六味地黃丸, 大補陰丸, 瓊玉膏 등

3) 출혈과다: 四物湯에 百合, 地黃, 白蜜, 天門冬, 天花粉, 人蔘, 白朮 등

4) 성대결절이 심하거나 성대에 폴립이 생긴 경우는 수술로 제거

급성 후두염

- 후두 점막의 급성 카타르성 염증으로서 후두 전체에 발생.

- 원인: 상기도 감염의 일부 증상. 대부분 바이러스나 세균에 의해 발생. 기후의 급변, 습도의 변화, 건조한 공기, 성대의 과용, 담배, 화학약품이 要因.

- 증상

① 주증상: 쉼소리(애성), 실성(성대 부종이 심해져), 흡기성 천명

② 부수증상

- 기침, 인후부의 건조감, 통증, 이물감, 38℃ 정도의 체온

- 후두분비물: 적은 양에서 점차 많아지고 때로는 혈액이 묻어 나오기도 함.

③ 성대증상: 성대 충혈 부종, 피열근 부위에 충혈 증창.

- 치료: 실내 온도 및 습도를 조절. 거담제, 항생제를 사용. 성대의 안정, 즉 **침묵 요법**을 필히 실시하며 한냉, 음주, 흡연을 금지.

만성 후두염

- 후두 점막의 지속적인 염증 → 건조한 양상으로 나타남

- 병리학상: 단순형, 만성형, 증식 혹은 비후형, 만성 성문하형, 건조형으로 분류.

- 원인

① 지속적인 후두자극: 음성남용, 담배, 매연

② 분비물의 자극: 기관지 확장증, 부비동염 등의 호흡기계통의 염증 → 분비물

③ 비폐색으로 인한 지속적인 구호흡: 부적당한 습도 → 혈관확장, 부종 → 점막하출혈 → 염증

- 증상

① 주증상: 음성의 변화로 쉼소리

② 후두의 자극증상: 이물감, 건조감, 소양감. 동통은 별로 없음.

③ 농후한 분비물이 있는 경우나 말을 하기 전에 습관적으로 기침.

- 치료: 원인제거 및 성대휴식. 적당한 습도 유지, 발성재교육

결절성 성대염

★ 음성 과용, 부정한 발성으로 교사나 가수와 같은 직업적인 음성 과용자에게 다발하며 특히 음성의 고저가 중요한 요인으로 작용하는 것으로, 막성성대의 중앙부에 속립상의 백색 또는 담홍색의 결절이 양측 혹은 편측에 나타나는 질환은? (00)

- "singer's nodules". 음성 과용, 부정한 발성으로 교사나 가수와 같은 직업적인 음성 과용자에게 다발. 특히 음성의 고저가 중요한 요인

- 20대 이전의 남자, 20대 이후의 여자에서 다발

- 증상

① 애성이 주로 일어나며 음성의 피로가 쉽게 오며, 고음에서 음성의 분열과 파열음 발생.

② 막성성대의 **중앙부의 자유연에 좁쌀크기**의 백색 또는 담홍색의 결절 → 가장 특징적

③ 결절주위에는 농후한 점액성 분비물이 붙어있는 경우도 있음.

- 치료

① 초기에는 침묵요법이 매우 중요. 결절이 작을 경우에는 6~8주간의 침묵으로 소실.

② 증상이 심하면 수술 현미경을 이용하여 후두미세수술을 시행.

③ 치료 후에도 발성습관과 침묵요법을 계속하여 재발을 방지.

후두용(vocal polyps)

- 섬유종으로 후두 **양성종양**의 일종 → 폴립

- 원인

① 후두 결절, 성대 남용과 같은 장기적인 2차적 손상에서 주로 발생.

② 성대손상이 장기적이 아닌 일시적인 손상이나 상기도 감염에서도 발생가능.

- 증상

① 주증상: 애성(크기와 장소에 따라 증세의 변화가 많음)

② 범발성 후두용: 호흡곤란과 천명, 좌우대칭의 소세지와 비슷.

③ 국한성 후두용: 후두결절의 호발부위와 같은 위치에 용종양(표면이 평활, 유연하고 창백색, 담홍색 또는 암적색을 띠는)의 병변. 유경성이면 발성에 따라 성문위로 돌출되는 것을 볼 수 있으며 대부분 한쪽 성대에 국한.

- 치료

① 국한성: 수술현미경하에 제거

② 만성 후두남용이 원인: 후두재교육

③ 범발성: 경미함(침묵요법), 대부분(수술)

失音(실음): 급성 성대마비

- 소리가 전혀 나오지 않는 상태.

- 종류

① 咳嗽失音: 기침이 오랫동안 호전되지 않고 오래 경과되어 肺癰 가 되고 眞陰이 고갈되어 발생. 咳嗽가 그치지 않으면서 말을 하고자 하여도 목소리가 나오지 않음.

② 風寒失音: 風寒이 갑자기 肺에 침범하여 肺氣 鬱結. 鼻塞, 身熱, 聲嘶하면서 失音.

③ 中風失音: 中風으로 인해 失音. 中風으로 음식이나 기거는 정상이면서 失音, 不語만 나타나는 상태. 癱風. → 가장 흔한 형태

④ 卒然無音: 寒邪가 會厭에 침범, 음주 후 風邪가 침입, 感冒 후 風寒에 감촉. 갑자기 言語不出, 咽乾, 鼻涕 등이 있다가 갑자기 聲嘎가 되거나 無音.

- 치료 → 실음보다는 그 원인을 제거하는게 중요

1) 咳嗽 甚: 蔘蘇飲, 二陳湯, 小青龍湯, 三拗湯 등

2) 火邪犯肺: 四陰煎

3) 風寒 감촉: 荊蘇湯, 人蔘荊芥散

4) 中風: 二瀝飲, 地黃飲子 → 지황음자 = 중풍으로 인한 언어장애

성대마비

1. 기능적 마비

- 히스테리성 실어증

- 젊은 여성에 호발

- 공포, 긴장, 불안으로 일시적인 내전근의 마비가 유발되어 운동피질중추의 급격한 빈혈에 의해서 無聲이 초래되는데, 이러한 현상은 기절이나 실신의 생리기전과 같음.

2. 기질적 마비

- 원인

① 중추성 마비 → 대뇌피질이나 연수의 문제

- 피질성 마비: 대뇌전장, 뇌염 및 미만성 뇌동맥 경화증

- 피질구성 마비: 기저동맥부전증

- 구성마비: 연수 의핵의 부분적 혹은 전파괴

- 그 외 진행성 구마비, 척수공동증, 다발성 경화증, 두뇌의 외상, 매독, 광견병 및 뇌염 등

② 말초성 마비(90%): 급만성 후두질환, 음성남용 / 갑상선 수술, 경부 외상, 신경성 질환, 악성 종양의 침범 등에서 발생

- 상부미주신경마비(상후두신경마비): 절상신경절 혹은 그 상부에 마비 → 침범된 쪽 후두의 모든근 마비

- 하부미주신경마비(반회신경마비; recurrent n.): 부분근육의 마비. 좌측 호발

성대마비 치료

- 완전한 신경 손상이 아니거나 원인미상의 경우 60% 이상에서 발생후 1년내에 자연 치유 가능. 최소 6개월 경과관찰 → 양방은 6개월 경과관찰 많이 시킴. 근데 이때까지 회복이 안되면 거의 고장났다고 보면 됨

- 조속한 음성회복을 요하는 경우 수술 시행

- 일측성 성대마비: 언어치료를 수술에 관계없이 시행. 수술전, 후 모두 적용 가능

- 양측성 성대마비: 기도확보를 위해 기관절개술. 성대외전술 시행

경련성 발성장애(spasmodic dysphonia)

- 후두에 국한하여 발생한 후두근육의 불수의적인 수축으로 인해 초래되는 발성장애.

- 원인: 과거 심리적 문제로 인식하였으나 최근에는 중추신경계 이상에 의한 국소성 이긴장증의 한 종류로 인식.

- 종류

① 내전형: 성대의 불수의적인 과내전으로 발생. 90% 차지. 수시로 음성이 끊어지고 목을 조이는 듯한 거친 목소리 발생.

② 외전형: 성대의 불수의적인 과외전으로 발생. 간헐적으로 바람이 새는 듯한 쉼 목소리 발생.

- 치료: 보툴리눔 독소 주입술(보톡스)이 가장 효과적. 정신요법, 언어치료, 약물요법(근이완제, 진정제, 항콜린제 등), 수술 시행. 예후 불량.

실어증

- 언어장애. 대부분 中風失音에서 발생. 주로 舌強不語, 神昏不語, 口噤不語, 舌縱言澁, 舌麻言澁. + 실어증은 중풍 쪽에 초점을 맞춰서 보기
- 이명: 言語蹇澁, 不語, 不能言, 瘖瘖, 不得言, 無言, 失音不語, 語澁.
- 홀연히 昏倒, 인사불성, 구안와사, 口角流涎, 반신불수, 수족탄탄, 偏枯, 口噤, 舌強不言으로 舌이 轉運되지 못해서 言語 難出.
- 분류: 舌瘖과 喉瘖
- ① 舌瘖: 舌本이 轉運하지 못해서 언어를 구성하지 못하는 것. 中風인 風癱, 風痺 에서 갑자기 昏倒하여 舌強해서 言語難出 및 失音이 되어 四肢不遂까지 나타나는 것. → 중풍
- ② 喉瘖: 인후병이 일어나 聲啞 및 嚔 聲, 혹은 嘶聲이 되는 것. 舌本은 정상적으로 轉運되나 聲音이 發하지 못하는 것.

<서양의학> 失語症(aphasia)

- 우위 대뇌 반구(주로 좌뇌)의 언어영역이 파괴되는 병변. 흔히 좌측의 내경동맥 및 중대뇌동맥의 폐쇄, 출혈, 종양과 대간질 발작 후 발생.

- 失語症의 分類

- ① Broca 부위 손상: Broca 실어증 - 발성근육 운동성 장애인 실어증.
- ② Wernicke 부위 손상: Wernicke 실어증 - 유창하게 말은 하나 상대방에게 전달이 되지 않는 감각신경성의 장애인 실어증.
- ③ 언어중추의 연결장애(각회 부위 손상): 전도성 실어증.

- 원인 및 치료 → 위에 4가지 정도만 알아두기

- ① 舌強不語, 口噤不語: 痰盛 - 滌痰湯, 導痰湯 加石菖蒲, 人蔘, 竹茹, 黃連, 黃芩 → 담
- ② 舌縱語澁不語, 舌麻語蹇不語: 風盛 - 資壽解言湯, 解言丸 → 풍
- ③ 神昏不語: 清神解語湯
- ④ 腎虛: 地黃飲子, 六味地黃湯에 遠志, 石菖蒲를 加
- ⑤ 肺腎陰虛: 百合固金湯, 麥味地黃湯
- ⑥ 亡血로 因해 氣血虛損: 十全大補湯加減, 四物湯加味
- ⑦ 風寒: 三拗湯
- ⑧ 痰熱: 清咽寧肺湯, 六君子湯 加膽南星, 木香, 石菖蒲, 遠志, 枳實, 竹茹
- ⑨ 氣鬱: 蘇子降氣湯, 紫胡清肝湯加減
- ⑩ 脾氣虛弱으로 痰涎壅塞: 六君子湯加味
- ⑪ 中風으로 因한 失語: 初起(理氣祛風湯, 清神解語湯, 防風通聖散, 星香正氣散, 導痰湯) 經過(順氣活血湯, 半夏白朮天麻湯, 地黃飲子, 補陽還五湯, 小續命湯加減)
- ⑫ 心血虛損으로 怔忡, 驚悸, 失語 - 祛風定志湯

失語와 語澁의 감별

- 失語: 中風 혹은 氣血 및 腎虛로 인해 발생. 언어를 정확하게 구사하지 못하고 말을 더듬게 되고 혹은 痰이 막혀서 말을 못하는 것.
- 語澁: 평소 腎虛한 중에 강한 風邪에 손상, 痰火가 上竅를 壅塞하고 氣虛하여 발생. 말을 빨리하지 못하고 항상 더듬게 되고 말하기가 힘들.

참고 인두의 증후성질한

1. 咽乾疾患: 인후 지각, 분비이상 또는 단순성, 과립성, 건조성 인두염

- 이명: 噤 乾, 噤 燥, 咽喉乾燥

1) 實火咽乾

- 증상

- ① 風熱: 咽喉乾燥, 灼熱感, 紅腫疼痛, 癢痒感이 있으면서 風熱表證을 兼
- ② 燥熱: 咽喉가 紅乾, 微痛痒, 乾咳, 痰少稠粘, 胸脇脹痛, 脈浮數 或 數
- ③ 脾胃熱盛: 咽乾, 口燥, 煩渴欲飲, 痛痒, 胃脘灼熱疼痛, 舌質紅, 苔黃, 滑數脈
- ④ 肝膽熱盛: 口苦咽乾, 紅赤痛, 心煩, 胸脇悶, 煩渴欲飲, 弦細脈

- 치료: 黃連瀉心湯, 涼膈散, 升麻石膏湯, 葛根解肌湯, 調胃承氣湯, 白虎加人蔘湯, 桑菊飲

2) 虛火咽乾

- 증상: 인후에 紅乾, 微紅赤, 微痛, 소양감 및 이물감이 나타나고 乾咳, 痰少稠粘하며 陰虛火旺한 증상과 兼하여 발생

- 원인: 肺腎陰虛로 津液 不足되거나 또는 虛火가 上炎하여 발생

- 치료: 養陰清肺湯, 百合固金湯, 六味地黃湯加減

<서양의학> 인두의 분비이상, 지각이상

★ 분비물의 감소로 발생하는 인건질환에 대해 서술 (02)

1. 인두의 분비이상

- 인두점막은 많은 점액선 분비물에 의하여 표면이 보호되는데, 특히 질병에 따라 분비물이 증진 혹은 감퇴됨.

① 분비물의 감소

- 매독, 결핵, 루프스, 위축성 인두염에서 감소되어 인두가 건조
- 위축성 비염, 비폐색으로 인한 구호흡을 하는 경우에도 건조
- 발열, 심한 출혈 후에도 건조

② 분비물의 증가

- 인두염, 편도염시 점조성 분비물
- 인두농양에서는 대량의 거품이 섞인 분비물
- 포진성 인두염에서도 분비물이 증가

2. 인두의 지각이상

① 지각과민

- 객연이나 음주가 심한 사람에서 다발. 인두염과 동반되는 경우가 많음.
- 자극을 동통으로 느끼게 되는데, 연하운동이나 설을 운동시킬 때 인두에 심한 동통을 반복해서 느낌. 때로 중양에서도 발생.

② 지각둔마

- 말초성 원인: 디프테리아, 인플루엔자, 히스테리, 비인강 종양 등
- 중추성 원인: 뇌종양, 다발성 경화증 뇌염 등

2. 懸雍垂: 급성 편도염, 인두염, 편도주위 농양으로 구개수 종창

- 懸雍이 腫大, 하수되어 舌根에 접촉
- 증상: 懸雍이 紅腫疼痛되어 數寸 정도로 하수, 인후에 灼熱, 이물감, 폐색감이 일어나며 口苦, 咽乾, 口臭, 胃脘脹悶, 噎氣, 大便秘結 등 발생
- 원인: 外感風熱이나 脾胃熱盛으로 火毒이 인후에 결취, 또는 氣滯血瘀, 이외 先天異常, 中氣下陷 등.
- 내치: 黃連解毒湯, 涼膈散, 甘桔湯, 清咽利膈湯, 清火補陰湯加減
- 외치: 鹽礬散을 懸雍에 敷貼. 吹喉散을 吹入. 玄蓼散을 含漱 또는 복용
- 鍼刺出血은 慎重히 하여야 한다.
- 서양의학: 목젖의 급성부종 (목젖의 급성 팽대는 외상, 알레르기 반응의 일부 또는 감염 과정의 일부로 발생할 수 있다.)

3. 梅核氣: 인두이상감각, 히스테리구(globus hystericus)

★ 매핵기에 대해 동서의학적으로 설명 (00)

- 증상: 氣機가 不利되어 인후에 이물감이 마치 梅核狀으로 梗阻해 있는 것처럼 느껴서 咯不出, 嚥不下, 즉 뱉어도 나오지 않고 삼켜도 넘어가지 않는 상태 → 간기울결과 연관
- 이명: 喉節, 梅核風, 回食丹, 咽癰, 癰球
- 원인 및 치료

① 情志抑鬱로 肝氣鬱結: 香蘇飲加味, 半夏厚朴湯, 加味四七湯과 逍遙散加味

- ② 脾虛痰聚: 加味二陳湯, 木香散, 四味湯
- ③ 肝胃不和: 旋覆代赭湯加減
- ④ 침구치료: 合谷, 內關, 太衝, 天突, 廉泉穴을 활용

<서양의학> 인두의 이상감각

- 신경질적, 과민한 환자에서 다발
- 히스테리, 척수로, 구마비, 고도의 빈혈, 위장장애에서 발생
- ① 히스테리구(globus hystericus)
 - 대개 **갱년기 전후의 여성**에 많음
 - 이물감을 없애려고 기침과 연하운동을 자주해 인두 점막에 경미한 발적, 염증과 소량의 분비물이 축적, 편도와에 나타나고 작열감, 압박감을 느끼며 심할 경우 지속적인 연하운동으로 空氣嚥下症과 위장장애 유발
- ② 분비성 신경증(Secretory neurosis)
 - 인두 이물감으로 끊임없이 가래를 뱉으려고 하는 증상
 - 뱉으려는 객담은 주로 거품이 있고 약간의 점액성을 띠며 목을 깨끗이 하고자 자발적인 운동을 함으로써 발생

후두의 증후성 질환 - 참고

★ 喉癰, 喉痧, 白喉, 喉癰의 양방병명 (08)

★ 다음 질환에 해당하는 서의학 병명 연결하십시오 (11,10,03,02)

1. 喉癰: 후두의 양성 및 악성종양

- 증상: 돌발적으로 인후종대, 癰 및 瘡瘍이 발생하여 동통이 극심하고 화농, 呑咽困難, 呼吸困難이 일어나는 것
- 이명: 猛疽, 咽喉生瘡, 咽喉生癰, 喉瘤
- 발병부위에 따른 분류
 - ① 關格, 즉 喉關에 발생하는 것 - 喉關癰, 騎關癰 - 편도부위의 腫瘍과 비슷 - 喉核과 喉關이 홍종, 돌출되어 외측으로 扁斜, 呑咽 및 開口困難, 口涎外溢, 言語含糊가 발생.
 - ② 喉底에서 발생하는 것 - 裏喉癰, 頭底癰 - 하인두 및 후두부의 腫瘍과 비슷 - 喉底部에 홍종, 돌기, 동통이 심하게 나타나면서 頸項強直, 口涎外溢, 言語不清, 呑咽困難하며 심할 경우에는 응증이 기도를 폐색하여 痰盛, 喘鳴, 氣急, 호흡곤란이 발생하여 생명이 위험.
 - ③ 頤下에 나타나는 것 - 頤下癰 - 중인두 또는 인두의 양방에서 발생하는 腫瘍과 비슷
- 초기에 오한, 발열, 두통이 발생, 喉中의 환처부에 腫核이 홍종동통하여 頤下 및 頸部に

까지 파급되며 동통이 심하여 呑咽 및 口開困難, 牙關緊急이 발생

④ 이외 會厭癰, 上顎癰(口中上顎部に 발생. 심하면 하수되어 舌部に 接觸), 下喉癰(돌연히 喉癰이 발생하여 동통이 극심하고 呑咽困難, 飲食不入이 일어나며 항시 후중에 硬物과 같은 이물감을 느끼고 聲音不暢 및 嘎聲, 痰鳴氣喘, 호흡곤란이 발생) 등

- 원인

① 평소 肺胃熱盛한 상태에서 外邪侵襲으로 內外熱毒이 결취

② 風熱喉痺, 風熱乳蛾, 纏喉風이 오래되어 발생

- 치료

① 내복 : 五味消毒飲(肺經風熱-輕症), 仙方活命飲加味(毒聚咽喉-中症), 清咽利膈湯加味

② 심하여 熱毒이 營血에 入 : 安宮牛黃丸, 犀角地黃湯(熱入營血-重症)

③ 陽明胃熱이 치성 : 白虎湯合五味消毒飲에 荊芥, 薄荷를 加

④ 氣血不足으로 癰腫이 이미 潰爛되나 瘡口가 융합되지 않음 : 托裏消毒飲加減

⑤ 외치 : 如意金黃散, 三黃散, 紫金錠을 外敷. 冰 硼散, 冰 麝散, 金丹, 碧丹을 吹入

<서양의학> 喉頭腫瘍

1) 후두의 양성종양 - 유두종, 후두연골종,

2) 후두의 악성종양

- 후두암(cancer of the larynx): 모든 악성종양의 4% 차지, 상악암, 식도암과 더불어 많이 발생하는 癌의 하나. 조직학적으로 95~98%가 편평상피암, 주로 남성에서 여성의 10배 호발, 50~70대 다발

- 부위에 따라서

㉠ 성대암(60~70%): 애성, 혈담 ㉢ 성문상부암(30%): 위화감, 연하통 ㉡ 성문하부암(2%)

- 진단: 40세 이상의 남자에서 1개월 이상 계속되는 진행성인 嘎聲이 있을 때는 우선 후두암을 의심. 특히 여자에서는 후연상부암이 호발.

이비인후부에서의 양성종양

- 호발부위: 상악동, 비인강 부위, 성대부근

- 변증: 肝氣鬱結, 肺經熱積

이비인후부에서의 악성종양

- 호발부위: 상인두암, 상악동암, 후두암

- 변증: 痰濁, 氣血凝滯, 火毒

2. 喉痧: 성홍열, 홍역, 인플루엔자, 장티푸스 등 급성 전염병

- 증상

① 인후가 홍중동통되면서 潰爛이 일어나고 전신에 痧疹이 발생해 색이 마치 丹을 도포해 놓은 것 같이 鮮紅하고 작은 것은 痧疹, 큰 것은 癍疹을 보이는 일종의 天行瘟疫.

② 喉痧의 증상은 주로 급성적으로 발생, 痧癍이 목에서 시작해 점차 가슴, 등, 배 혹은 사지로 퍼지며 하루 사이에 전신에 나타나는데 특히 頭面에 痧癍이 발생되면 難治.

- 이명: 瘟痧, 時喉疫, 爛喉痧, 爛喉丹痧, 疫喉痧, 瘟痧, 丹疹

- 원인

① 瘟疫邪, 癘氣가 口鼻로 入하여 肺胃에 침범

② 상한병에 表邪가 완전히 제거되지 않을 때 熱毒이 上焦氣分에 응결

- 치료

① 초기에 瘟疫과 겸하여 邪毒이 肺胃에 침범 : 荊防敗毒散, 清咽利膈湯

② 심해져 裏熱이 盛 : 加減麻杏石甘湯, 清心涼膈散, 清咽消毒飲

③ 邪毒이 營血에 침입 : 犀角地黃湯, 涼膈散合玉女煎加減

④ 邪毒이 心包에 內陷 : 安宮牛黃丸, 至寶丹, 紫雪丹

⑤ 表散을 너무 太過하여 火가 動하면 肝風도 動하게 되어 瘰癧 : 清營湯

⑥ 초기에 한냉한 약물을 과다하게 복용하여 泄瀉 : 加減升麻葛根湯

⑦ 외치: 錫類散, 金不換散, 珠黃散 吹藥, 三黃二香散, 沖和膏, 紫金錠 外敷

⑧ 침구치료: 少商, 委中, 尺澤, 曲池穴을 鍼刺出血, 동시에 合谷穴에 瀉法

⑨ 예방: 瘟癘은 전염성이 강하여 격리를 하고 金銀花, 蒲公英을 蜜糖에 섞어서 복용하거나 生橄欖, 生蘿菈子을 水煎服하여 수시로 마시거나 蘿菈 數片을 복용.

<서양의학>

- 증상: 돌연히 39~40℃의 高熱로 시작되어 사지통, 근육통과 함께 1일후 전신에 발진성 皮疹 발생. 후두 점막에 발적, 반점, 출혈, 궤양이 생겨서 연하통, 嘎聲이 발생되고 심해지면 喘鳴과 호흡곤란도 동반. 가끔 위막성 후두염의 증상을 띠기도 하고 디프테리아, 폐렴과 합병되기도 함.

悶喉痧: 疫喉痧 중에서 가장 극심한 것으로 생명이 危險한 重症 - 참고

- 원인: 熱毒이 울체되고 왕성해서 瘟毒 內陷되어서 발생.

- 증상: 인후가 부식되어 연하곤란, 高熱, 心煩, 전신이 紫赤色을 띠고 과립이 붙으며 사지가 寒冷하고 面靑, 目瞪.

- 치료: 신속히 通關散으로 搗鼻, 紫雪丹을 注入, 小商穴 出血, 清咽利膈湯.

3. 白喉: 인두 및 후두 디프테리아, 후두각화증

- 인후가 종통되고 인후의 肌膜에 白點, 白條, 白塊狀이 일어나며 심할 경우에는 연하 및 호흡곤란이 발생하는 瘟疫病의 일증.

- 이명: 白喉瘟疫, 白纏喉風, 白色喉風, 白喉嚨, 蛾風白喉, 瘟毒喉痺

- 風熱邪가 肺胃에 침범하거나 선천적으로 氣質이 허약한 사람이 辛熱物을 과다하게 섭취하여 발생하고, 크게 風熱白喉(肺胃熱盛)와 陰虛白喉(肺腎陰虛)로 구분.

- 원인 및 치료

① 초기: 荊防敗毒散加減, 清咽消毒飲, 除瘟化毒湯, 銀翹散加味

② 瘟毒內盛: 清咽利膈湯, 清心涼膈散, 普濟消毒飲, 三物白散加減

③ 肺胃熱盛: 龍虎二仙湯合神仙活命飲에 白殭, 蠶, 蟬蛻, 土茯苓을 加

④ 肺腎陰虛: 養陰清肺湯에 牛膝 加

⑤ 邪毒 內陷되어 危險: 雄黃解毒丸, 犀角地黃湯加減, 大定風珠加味

- 외치

① 白喉散, 清涼散, 錫類散, 加味珠黃散을 吹藥

② 牛膝根을 水煎하여 含漱

③ 異功散, 三黃二香散, 冲 和膏, 太乙丹을 경향부에 外敷

- 침구치료

① 少商, 委中, 中衝, 合谷穴을 刺鍼瀉血.

② 合谷, 尺澤, 足三里, 中衝, 天突, 人中穴을 함께 刺鍼,

③ 耳上の 紫筋과 舌下の 紫筋部를 放血.

- 위막은 회백색 혹은 약간 누런색을 띠며 광택이 있고 변연은 경계가 명료함.

- 음허형에서는 일반적으로 국한되나, 풍열형에서는 점차 커지며 퍼져서 목젖, 후두까지 파급되고 기관까지 파급되면 호흡장애를 일으킴

<서양의학> 인후 위막성질환 (인두, 후두 디프테리아, 후두각화증)

1. 인두 디프테리아

- 만 1세 이하 또는 성인에서는 적고 12~13세 이하의 소아에서 다발.

- 원인: 디프테리아균의 감염. 주로 음식물이나 생활환경과 밀접. 계절성(10월~3월까지의 寒節 다발)

- 증상

① 1주일 내외 잠복기 후 연하통, 인두통, 발열, 두통과 특유한 口臭, 구강 및 인두점막에 발적, 종창이 있다가 회백색 위막이 구강, 편도, 인두, 구개수, 연구개에 파급.

② 위막은 하층조직과 단단히 부착되어 벗기기가 곤란하며 무리하게 벗기면 출혈. 심하

면 비강, 후두, 기관에 까지 파급, 후두에 파급되면 嘎聲과 호흡곤란 발생. 重症에서는 신염, 근육마비, 패혈증도 동반.

2. 후두 디프테리아

- 디프테리아균에 의해 발생되나 인두 디프테리아에서 속발.

- 증상

① 초기에는 1주일 내외의 잠복기 후에 인두통, 오한, 발열이 일어나다가 후두에 파급되어 嘎聲과 犬吠樣 咳嗽가 발생.

② 嘎聲은 건조 및 협착성으로 나중에는 無聲에 까지 이르고 위막 형성 및 종창에 의해서 얼굴이 창백해지며 冷汗, 흡기성 호흡곤란, 천명이 증가되어 경련이 일어남.

③ 위막은 후두개의 내면 성대부와 후두내강에서 황색, 회백색을 띠며 제거하면 출혈이 발생.

4. 喉癰: 후두의 결핵, 낭창, 나병, 진균, 매독

- 喉內가 소양, 홍종동통, 건조불쾌하면서 肌膜이 궤란 및 미란하고 喉間의 변연은 鼠咬한 것처럼 腐衣가 苔蘚 형태를 띠며 심할 경우에는 嘶啞, 咳嗽, 痰血을 吐하는 것.

- 이명: 天白蟻, 尸咽, 尸蟲, 肺火瘡

- 원인 및 치료

① 肺腎陰虛: 百合固金湯加味, 知柏地黃湯合四物湯加味, 桂附八味丸加味

② 胃熱積盛: 초기 오한발열(加減荊防敗毒散), 熱盛(清咽利膈湯, 清肺去癢湯, 廣筆鼠粘子湯, 百合固金湯에 生石膏, 知母를 加)

- 궤양이 되지 않았을 때는 礬精散을 살포, 궤양이 있으면 清涼散 복용.

- 외치: 珠黃散, 冰硼散, 錫類散을 吹藥하고 柿霜을 含漱한다.

- 虛啞喉, 聲啞喉, 虛火聲啞, 喉疳, 虛火喉痛, 喉瘡에 포함, 혹은 傷寒狐惑症과 유사

- 증상

① 肺腎陰虛: 喉中이 종대되지는 않으나 微紅하고 喉中의 반점이 靑色이나 白色을 띠며 형태가 마치 芥子, 鍼孔, 綠豆大 같으며, 반점이 일어날 때마다 砭刺과 같은 동통이 있고, 飲水하면 동통이 극렬하며 聲啞, 咳嗽無痰하게 되고 악화되면 궤란이 만연되어 蟻蝕狀을 보임.

② 胃熱積盛: 처음에 소양감을 느끼며 苔癰이 발생. 喉中이 暗紫色을 띠고 홍종동통이 극심하며 煩熱, 癢痒, 苔蘚이 있고 악취가 있는 痰涎을 吐하며 呑咽困難이 발생.

<서양의학>

1. 후두결핵

- 重症의 활동성 폐결핵 환자에서 병발.

- 증상: 초기에 嘔聲, 작열감, 이물감, 기침이 일어나며 쉽게 음성이 피로해짐. 궤양은 얇으며 창백하고 紅色 혹은 赤色の 肉芽와 얇은 膿汁으로 덮여 있으며 궤양연은 鋸齒狀으로 충혈, 종창됨. 특히 후두 입구부 부근의 궤양이나 피열연골 혹은 후두개의 연골 막염이 일어나면 격심한 연하통 및 發聲痛과 귀로 방산되는 동통이 발생. 후두 협착이 되면 호흡곤란도 발생.

2. 후두낭창

- 후두루프스로 만성적인 경과를 취하는 일종의 후두결핵.

- 연하통과 연하장애는 극히 드물고 후두에 침범할 경우에만 嘔聲이 발생. 후두결핵과 마찬가지로 상피하조직에 결절성의 침윤을 형성, 점차적으로 표재성 궤양이 발생.

3. 후두 진균증(laryngomycosis)

- candida에 의한 감염으로 인해 심재성 궤양이 형성. 후두개, 피열연골부에 표재성의 小白斑의 부착을 보이고 때로 심한 동통을 유발. 주로 구내염의 일종인 아구창과 병발.

4. 喉頭癩(leprosy of the larynx)

- 癩菌에 의해 유발. 후두점막에 침윤, 대소의 결절 및 궤양.